Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55) 3412-1410 - Balcão Virtual (55)99913-2599 - Email: fruruguaia2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007303-04.2023.8.21.0037/RS

AUTOR: TANIA REGINA BARBOSA MENDES
ADVOGADO(A): CATIANE ALINE STOLL (OAB RS099997)

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

TANIA REGINA BARBOSA MENDES ajuizou a presente ação em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL,** ambos qualificados na inicial (evento 1, INIC1). Disse que é beneficiária do plano IPE-SAÚDE, inscrição nº 66.96131845.00.9, possuindo cobertura ambulatorial e hospitalar. Aduziu que é portadora de neoplasia maligna de rim, estágio clínico IV (metástico), patologia identificada pelo CID C64. Esclareceu sobre os procedimentos médicos e exames realizados até que se chegasse ao diagnóstico de cancer renal de células claras, referindo que apresenta metástases cervicais, em parótida direita, além de metástases pulmonares, retroperitoneais, implantes em peritônio, tronco celíaco e metástase com fratura patológica em ísquio esquerdo. Referiu que o perfil agressivo da doença, associado a sintomas severos e a idade da autora, limita as opções de conduta terapêuticas possíveis, afirmando ser primordial que seja realizado tratamento de forma imediata com protocolo terapêutico de primeira linha, que oferece os melhores desfechos clínicos com segurança. Argumentou que, diante do quadro, o médico assistente indicou, como única alternativa terapêutica viável, o tratamento por meio da associação dos fármacos *pembrolizumabe* e *axitinibe.* Defendeu que o protocolo é adequado para suas condições clínicas e é considerado padrão ouro para casos análogos ao da requerente, fazendo parte, inclusive, do rol de obrigatoriedades da ANS. Repisou que o tratamento prescrito decorre de sua peculiar condição diante do estágio avançado da doença, referindo, ainda, que não há tratamento compatível com seu quadro dentre as opções disponibilizadas pelo réu. Asseverou que a abordagem terapêutica prescrita é a única alternativa viável para o correto tratamento da doença. Argumentou que a terapia indicada é aprovada pela ANVISA, com indicação em bula, para portadores de neoplasia maligna de rim, estágio clínico IV (metastático). Disse que, tão logo prescrito o tratamento, buscou o autorização para o tratamento junto ao réu, mas teve o pedido negado. Sustentou que, em se tratando de tratamento oncológico de uso restrito hospitalar é de fornecimento obrigatório dos planos de saúde que estão sujeitos à Lei n° 9.656/98, sendo injustificável a negativa do requerido. Citou disposições contidas na Lei Complementar n° 12.134/04. Repisou, veementemente, que o protocolo prescrito é a única alternativa para seu caso. Asseverou que a cobertura do tratamento que lhe fora prescrito é de total responsabilidade do réu. Sustentou que a recusa do requerido se revela arbitrária e ilegal, pois o tratamento pretendido está expressamente previsto no Regulamento da Entidade Operadora de Plano de Saúde, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Citou entendimento jurisprudencial sobre o tema, aduzindo que a ausência de previsão de cobertura no regulamento do réu não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido, colacionando excertos. Discorreu sobre o pedido de tutela de urgência e necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Requereu, em sede liminar, o fornecimento pelo réu dos medicamentos *pembrolizumabe* e *axitinibe*, nas quantidades indicadas, ou o bloqueio de valores para aquisição dos fármacos. Postulou o reconhecimento da relação de consumo existente entre as partes. Ao final, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência e condenação do réu à dispensação dos fármacos *pembrolizumabe* e *axitinibe*, nas quantidades e dosagens necessárias ao tratamento da autora. Pugnou pela concessão do benefício de gratuidade de justiça e juntou documentos.

Na decisão do evento 3, DESPAOFC1, deferiu-se o benefício da gratuidade de justiça, assim como o pedido de tutela de urgência, determinando-se ao requerido que fornecesse ao autor os medicamentos *axitinibe* 5mg (nome comercial Inlyta), na quantidade de 01 comprimido 2x ao dia, por tempo indeterminado; e *pembrolizumabe* 100mg (nome comercial Keytruda), na quantidade de 04 ampolas (ou 400mg) a cada 06 semanas, por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio de valores.

No E9, aportou informação de cumprimento da medida liminar.

Citado eletronicamente (E7), o réu apresentou contestação (evento 17, CONT1). Disse que possui protocolo oncológico elaborado pela Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul, que prevê quais medidas devem ser utilizadas em cada neoplasia, nos diferentes estágios e tratamentos. Alegou que não pode admitir nem ser compelido à cobertura de um tratamento de custo elevado e que excede o previsto por seu regulamento, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Arguiu que a pretensão da requerente é ilegal, pois pretende tratamento diferenciado e que não será estendido aos demais segurados, afrontando, assim, ao princípio da isonomia. Esclareceu que os medicamentos pleiteados pela autora não estão previstos no protocolo oncológico adotado pelo IPE-Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada. Argumentou que sem a comprovação de evidências científicas da eficácia, acurácia, efetividade e segurança de um medicamento, ele não pode ser disponibilizado pelo SUS. Discorreu sobre a prescrição e utilização de medicamentos desprovidos de evidências científicas de segurança e eficácia. Citou legislação, referindo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, detém a atribuição de de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fns do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Argumentou ser inviável concluir que o rol criado é meramente exemplificativo e de cobertura mínima. Mencionou que a assistência à saúde por si prestada foi reorganizada pela Lei Complementar n° 156145/2018, colacionando dispositivos legais. Arguiu que, considerando que se trata de plano de natureza pública, está adstrito à regulamentação administrativa, de modo que inaplicáveis as legislações relacionadas aos direitos do consumidor e demais planos de saúde. Mencionou que se trata de plano de saúde público, não equiparável ao SUS ou aos planos privados, pois consiste em plano de participação voluntária e com cobertura determinada,

prevista em lei e atos administrativos, fundamentado nos princípios da coparticipação financeira do usuário e da prestação de serviços, mediante o credenciamento de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde. Asseverou que inexistindo norma jurídica ou contrato que autorize o tratamento que não integra as tabelas de cobertura do IPE-Saúde, é ilegal a pretensão deduzida. Afirmou que os fármacos pleiteados pela autora, axitinibe e pembrolizumabe, não estão previstos na Instrução Normativa IPE-Saúde n° 02/2021. Citou que, para o tratamento de neoplasia de rim, há outros fármacos disponíveis. Discorreu sobre a sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde - FAS, arguindo que a procedência de demandas como a presente não é a garantia de um direito individual, mas a gradual dilapidação dos recursos do Fundo, que expõe a perigo toda a coletividade de beneficiários do IPE-Saúde. Colacionou enunciados do CNJ relacionados ao avanço da judicialização da saúde e risco aos recursos públicos. Sustentou a necessidade de apresentação periódica de laudos atualizados pela requerente, com reavaliação do caso e resultado de exames que comprovem os benefícios do fármaco na sobrevida livre de progressão da doença. Requereu a improcedência da ação e juntou documento.

Não houve réplica (E20).

Intimada a dizer sobre o prosseguimento do feito (evento 21, ATOORD1), a autora manifestou-se pela procedência da ação (evento 25, PET1).

Intimados sobre o interesse na produção de outras provas (evento 27, DESPADEC1), o réu informou não ter provas a produzir, além daquelas que já constam nos autos (evento 31, PET1). A autora silenciou (E32).

O Ministério Público deixou de exarar parecer (evento 37, PARECER1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora requer a condenação do réu ao fornecimento dos medicamentos *axitinibe* 5mg (nome comercial Inlyta), na quantidade de 01 comprimido 2x ao dia, por tempo indeterminado; e *pembrolizumabe* 100mg (nome comercial Keytruda), na quantidade de 04 ampolas (ou 400mg) a cada 06 semanas, por tempo indeterminado, a fim de tratar a moléstia que lhe acomete, consistente em neoplasia maligna de rim, estágio clínico IV (metástico), patologia identificada pelo CID C64.

A obrigação de fornecimento do tratamento de saúde ora perseguido pela parte autora decorre da Constituição Federal.

Verifica-se nos autos que a requerente é filiada ao IPE-Saúde (evento 1, OUT5), e que está acometida de carcinoma renal de células claras (CID C64), com metástases cervicais, parótida direita, pulmonares, retroperitoneais, implantes em peritônio, tronco celíaco e metástase com fratura patológica em isquio esquerdo.(evento 1, LAUDO8).

Com efeito, cumpre registrar que, em 06/04/2018, entrou em vigor a **Lei Complementar n° 15.145/2018** - que revogou a Lei Complementar nº 12.134/2004 - dispondo sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, §1º). Veja-se:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*

Contudo, a ausência de previsão do medicamento no protocolo do plano de saúde não pode ser suficiente para excluir o direito da parte autora ao tratamento prescrito como sendo o mais adequado ao seu diagnóstico.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido da impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Senão vejamos:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PREVISTO EM TABELAS PRÓPRIAS. LEI 9.656/98. RECUSA ILEGAL.* ***1. O plano de saúde, inclusive no regime de autogestão, não pode excluir de sua cobertura procedimento, medicamento ou material para tratamento de doença prevista no contrato. Jurisprudência do STJ. 2. Afigura-se ilegal a recusa do IPE-SAÚDE em custear procedimentos, exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento à saúde do segurado, ainda que que não constem das suas tabelas. Precedentes deste Tribunal. Hipótese em que há, nos autos, prova da necessidade dos medicamentos requeridos.*** *Recurso provido.(Agravo de Instrumento, Nº 53862359320238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 08-03-2024)*
>
> *Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSIDERAÇÕES. 1. DO DIREITO AO TRATAMENTO. A necessidade do tratamento de saúde está comprovada nos autos, bem como a filiação da parte autora perante o IPÊ-SAÚDE. Subsunção, in casu, dos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar/RS n. 15.145/2018. 2. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais. 3. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL. O argumento de que o tratamento não pode ser concedido em razão de não constar nos atos normativos editados pelo IPÊ-SAÚDE não prevalece diante do princípio constitucional da legalidade, pois ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II, da CF/1988).* ***A lei estadual não exclui a responsabilidade do plano de saúde de custear tratamento oncológico ao segurado, que contribui mensalmente para receber a assistência quando precisar. Limitações abusivas não prevalecem diante das normas constitucionais que garantem o direito à vida.*** *4. DO BLOQUEIO DE VALORES. Tratamento de saúde com custo*

elevado. Bloqueio de valores na conta do IPÊ-SAÚDE. Necessidade de três orçamentos. Observância daquele de menor valor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50013496620158210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 12-05-2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) E AXITINIBE (INLYTA) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Apelo da parte autora: Hipótese dos autos em que o recurso da parte autora versa exclusivamente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. O procurador da parte autora não é beneficiário da gratuidade judiciária, não efetuou o preparo no ato da interposição da apelação (art. 99, §5º, do CPC), tampouco atendeu à determinação para proceder ao pagamento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC/15. Nesse contexto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade, imperioso não conhecimento do recurso, porquanto deserto. Apelo da Autarquia: Fornecimento de medicamentos fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. ***Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.*** *APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50090431620218210021, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2022). Grifei.*

Aliado a isso, tem-se a Resolução nº **21/79** do IPÊ-Saúde, que regulamenta a assistência médico-hospitalar do IPERGS e prevê, em seu art. 2° que *o Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento,* inclusive em área oncológica, conforme se denota da previsão contida no art. 8° da mesma Resolução:

Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, ***Oncologia****, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia. - grifei*

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SAÚDE. SEGURADA DO IPE-SAÚDE.TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DE FORNECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. ***1. Considerando que a negativa administrativa ocorreu após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 15.145/2018, aplicável tal legislação ao caso em tela. 2. Embora o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Logo, descabe interpretação restritiva, pois a responsabilidade quanto ao fornecimento do tratamento indicado, a fim de possibilitar o tratamento ao paciente - segurado, está atrelada ao que dispõe o referido artigo 2° da Resolução nº 21/1979, ou seja, "os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento". A fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido. A prova constante dos autos dá conta da indicação médica para tratamento oncológico vindicado, sob risco de morte da paciente, restando cogente a manutenção da condenação ao fornecimento do tratamento.*** *3. Por outro lado, diante da identidade axiológica da questão presente com o REsp 1.657.156-RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 25/04/2018, referente ao Tema nº 106, em face da semelhança dos direitos em conflito, imperioso exigir-se, para medicamentos fora da lista dos fornecidos pelo IPE-SAÚDE, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da (a) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pela autarquia, e a (b) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Na hipótese contida nos autos, os laudos comprovam a imprescindibilidade tratamento. Outrossim, não há dúvida de que o medicamento está devidamente registrado junto à ANVISA. Ademais, é necessário considerar que o médico assistente é quem detém a capacidade/perícia de indicar o melhor medicamento, de acordo com a eficácia que apresenta, para fins de curar ou minimizar a enfermidade que acomete a paciente. Nesse contexto, não se há de admitir a negativa da autarquia. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários. No entanto, as ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não se havendo falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Posição deste órgão fracionário. Ademais, tanto antes do julgamento do Tema 1076 como depois, o entendimento do Tribunal da Cidadania vai na direção de que, nas causas envolvendo tratamento de saúde, admite-se o juízo de equidade, no que diz com os honorários, porquanto o proveito econômico em tal situação é, em regra, inestimável. Redução da verba honorária para patamar adotado por esta Câmara. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50016589320228210146, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 07-02-2024)*

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID 10-C50.9). FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ABEMACICLIB E FEMARA. NEGATIVA DE COBERTURA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. CONCESSÃO DA TUTELA EM SEDE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a demandante, segurada do IPERGS, foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID10 C50.9), necessitando das medicações prescritas por seu médico assistente para controle da referida doença, sendo indeferida, na origem, a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco, cuja dispensação fora negada na via administrativa. ***2. Descabe a negativa da Autarquia, já que, naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura (no caso, oncologia), entende-se que ela deve ser a mais ampla possível, lembrando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 21/79 são cobertos pelo IPE-SAÚDE "os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento" e que o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 prevê "cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos", não se podendo admitir que o tão-só fato de a medicação prescrita não estar contida em critérios técnicos do IPE-SAÚDE seja óbice à determinação de cobertura.*** *Precedentes deste TJ/RS. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 53171078320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 18-12-2023). Grifei.*

Ademais, o laudo médico acostado aos autos no evento 1, LAUDO8, revela a evolução da patologia que acomete a parte autora e a necessidade de utilização do fármaco prescrito de acordo com o quadro de saúde apresentado pelo paciente.

Portanto, resta evidenciado o direito da parte autora, enquanto beneficiária, de postular ao IPERGS/IPE-Saúde o fornecimento da medicação necessária ao tratamento, mesmo que os fármacos não integrem seus protocolos ou listas, porquanto se trata de medicamento indispensável à manutenção da sua saúde e relacionado a patologia prevista no contrato.

Nesses termos, a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência, é medida impositiva.

Por fim, no tocante ao arbitramento dos honorários, considerando que se trata de ação que envolve direito à saúde, matéria cuja natureza não é de grande complexidade, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (**TEMA 1076**), firmou a seguinte tese:

> *i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.*
>
> *ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.*

Com efeito, no caso em apreço, considerando o alto valor atribuído à causa e sua baixa complexidade, desproporcional a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, devendo esta ser feita de forma equitativa porquanto <u>inestimável o proveito econômico da demanda</u>, já que se trata de ação na qual o pleito é, em suma, o fornecimento de tratamento médico e a garantia do direito à vida e à saúde da parte autora.

Nesse sentido:

> ***Ementa:*** *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 EXCEPCIONADA NOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM DIREITO À SAÚDE E QUE TENHAM COMO PARTE VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE, TENDO EM VISTA O PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PARA R$ 2.500,00, QUANTIA QUE MELHOR SE AMOLDA AOS VALORES PRATICADOS PELA CÂMARA EM AÇÕES PARELHAS. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50041452520238210009, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 14-05-2025)*

Derradeiramente, com base nos documentos acostados pelo autor no evento 1, CHEQ4, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça, ora registrado.

Pelo exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizada por **TANIA REGINA BARBOSA MENDES** em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL,** para tornar definitiva a liminar deferida e determinar ao requerido que providencie o tratamento recomendado a autora, com o fornecimento dos medicamentos *axitinibe* 5mg (nome comercial Inlyta), na quantidade de 01 comprimido 2x ao dia, por tempo indeterminado; e *pembrolizumabe* 100mg (nome comercial Keytruda), na quantidade de 04 ampolas (ou 400mg) a cada 06 semanas, por tempo indeterminado*,* sob pena de custeio do tratamento necessitado, mediante bloqueio de valores.

Isento IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Por outro lado, condeno o IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL ao pagamento dos honorários sucumbenciais que hora arbitro em R$ 2.000,00, fixados levando em conta os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2°e 8° do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra. O valor deverá ser atualizado unicamente pela taxa *selic,* em atenção à implementação imposta pela Emenda Constitucional n° 113/2021, a partir da presente decisão.

Publicação e registro eletrônicos. Agendada a intimação das partes pelo sistema.

Em caso de interposição de <u>apelação</u>, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, no prazo legal, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2º, do CPC.

A seguir, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com retorno dos autos, intimem-se as partes e/ou transitada em julgado a presente decisão, cumpridas as determinações finais da sentença passíveis de cumprimento *ex officio* e, nada sendo requerido, recolhidas eventuais custas pendentes ou adotadas as providências para sua cobrança administrativa, **arquivem-se.**

Documento assinado eletronicamente por **KARINA DE OLIVEIRA LEONETTI PADILHA, Juíza de Direito**, em 26/06/2025, às 14:11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10085138249v3** e o código CRC **ffba87a5**.